



ANNALES OFFICIELLES EVC

EVCF 2009

Épreuve de vérification des connaissances fondamentales

Médecine générale (code 71)

SUJETS

4

QUESTIONS

23

SUJET

01

Cas clinique · 6 questions

VIGNETTE CLINIQUE

Un homme de 55 ans consulte pour une hypertension mal contrôlée sous bithérapie par 1 ESIDREX® (Hydrochlorothiazide) 25mg/j + AMLOR® (Amlodipine) 5mg/j. Sa pression artérielle au cabinet médical est à 155 / 92 mmHg. Il a un poids de 88 kg pour 1.70 m avec un tour de taille à 106 cm. Il boit régulièrement (chaque jour) 8 verres standards de boissons alcoolisées et fume 30 cigarettes par jour depuis 20 ans. Son bilan sanguin à jeun montre une kaliémie à 3.2 mmol/l et un profil lipidique avec 2.60g/l de cholestérol 0.35 g/l de cholestérol HDL et 2.20 g/l de triglycérides sans traitement hypolipémiant.

1

QUESTION 1

Calculer l'index de masse corporel (IMC).

2

QUESTION 2

Définir le type de morphologie : poids normal surpoids obésité androïde obésité morbide maigre

3

QUESTION 3

Calculer sa consommation d'alcool en g/j.

4

QUESTION 4

Calculer sa consommation totale de tabac en paquets / années.

5

QUESTION 5

Quel est le mécanisme le plus probable de son hypokaliémie ? alcool diurétique hypéraldostéronisme primaire laxatifs consommation de réglisse

6

QUESTION 6

Quelles sont les 3 causes les plus probables de résistance au traitement anti-hypertenseur ? dyslipidémie alcool mauvaise observance thérapeutique hypertension secondaire surcharge pondérale

SUJET

02

Cas clinique · 6 questions

VIGNETTE CLINIQUE

Un homme de 35 ans sans antécédent connu, arrive aux urgences pour dyspnée aiguë, fièvre à

40

QUESTION 40

C avec douleur basithoracique droite. Les symptômes ont débutés brutalement la veille au soir. Vous suspectez une pneumonie franche lobaire aiguë droite.

1

QUESTION 1

Quels critères de gravité recherchez-vous parmi les propositions suivantes ?
expectoration purulente état de choc fréquence respiratoire $>30/\text{mn}$ frissons
sommolence et/ou confusion

2

QUESTION 2

Quel germe paraît le plus probable ? Escherichia coli H1N1 Haemophilus influenza
Mycoplasma pneumoniae Streptococcus pneumoniae

3

QUESTION 3

Quelles sont les caractéristiques microbiologiques de ce germe ? cocci
GRAM-positif cocci GRAM-négatif diplocoque bacille GRAM-négatif virus

4

QUESTION 4

Les gaz du sang effectués en air ambiant montrent les résultats suivants : PH
7.40 - $\text{PO}_2 = 55\text{mmHg}$ - $\text{PCO}_2 = 30\text{mmHg}$ - $\text{HCO}_3 = 24\text{mM}$ - $\text{SaO}_2 = 89\%$
Comment calculez-vous l'eff et shunt ? Ce patient a-t-il un eff et shunt ? justifiez
par un calcul.

5

QUESTION 5

Quel est le mécanisme d'action de la pénicilline ? se fixe sur la sous-unité 30s du
ribosome inhibe la synthèse du peptidoglycane se fixe sur l'ADN-gyrase inhibe la
thymidine kinase inhibe la protéase

SUJET

03

Cas clinique · 6 questions

VIGNETTE CLINIQUE

Une femme de 76 ans consulte son médecin pour le suivi d'un diabète de type 2 équilibré par régime. Elle ne fume pas, elle ne boit pas. Elle n'a pas de symptôme actuel. Son examen clinique est normal hormis une pression artérielle à 170/80 mmHg, un IMC à 32 kg/m² et un pouls irrégulier. Son bilan sanguin est normal (HbA1c à 6%) sauf la TSH à 0.1 UI/L avec FT4 à 16 pg/ml. L'électrocardiogramme montre une arythmie complète par fibrillation auriculaire avec rythme cardiaque moyen à 82 bpm.

1

QUESTION 1

Quels sont les facteurs favorisants possibles de son arythmie ? hyperthyroïdie hypertension artérielle abus d'alcool infection aiguë hypothyroïdie

2

QUESTION 2

Quelle(s) complication(s) cardiovasculaire(s) cette arythmie fait-elle craindre ? infarctus du myocarde phlébite dysfonction cardiaque accident vasculaire cérébral ischémique accident vasculaire cérébral hémorragique

3

QUESTION 3

Quels éléments permettent d'apprécier le risque cérébro-vasculaire de cet arythmie cardiaque (score de Chads) ? antécédent personnel d'accident vasculaire cérébral hypertension artérielle diabète insuffisance cardiaque congestive âge > 75 ans sexe féminin IMC > 30 kg/m²

4

QUESTION 4

Que prescrivez-vous comme traitement antithrombotique au long cours ? Aspirine Anti-vitamine K Plavix Cordarone Statine

5

QUESTION 5

Quel est l'élément de surveillance du traitement anti-thrombotique choisi ?

6

QUESTION 6

Chez cette patiente la Cordarone est contre indiquée. Quels sont les mécanismes d'interaction entre la Cordarone et les hormones thyroïdiennes :

- Bloque la transformation périphérique de T3 en T4
- Bloque la transformation périphérique de T4 en T3
- surcharge iodée dans l'organisme
- diminue le taux de cholestérol sanguin
- se fixe à la thyroglobuline

SUJET

04

Cas clinique · 5 questions

VIGNETTE CLINIQUE

Un homme de 60 ans consulte pour la prise en charge d'un myelome multiple.

1

QUESTION 1

Parmi les immunoglobulines suivantes quelle est la seule qui n'est jamais rencontrée dans le myélome multiple ? IgA IgG IgE IgM Chaîne légère Kappa

2

QUESTION 2

Sa calcémie est à 2,51/mM, ses protides totaux à 86g/L, son albumine à 28g/L. Calculez la calcémie corrigée en mM.

3

QUESTION 3

Quelle prolifération cellulaire est responsable du myélome ? Lymphocyte B Lymphocyte T Plaquettes Plasmocyte Macrophage

4

QUESTION 4

Mécanisme d'action des Biphosphonates ? Chelateur de calcium Apoptose de fibroblaste Action antiostéoclastique Inhibition de la réabsorption tubulaire du phosphore Inhibition de la calcium -Binding Protein

5

QUESTION 5

Parmi les examens suivants, quel est celui qui est contre indiqué au cours du myélome ? Echographie rénale Ostéodensitométrie Scintigraphie osseuse Radiographie standard Tomodensitométrie avec injection de produit de contraste iodé.